内科含诊断 支气管哮喘（含奇脉小结）★★★（0~3题）

遗传 - 环境（2024）

- 炎细胞及气道上皮细胞 —— 气道慢性炎症（嗜酸性粒细胞为主）、重构
- 神经调节失衡 —— 气道高反应性 ← 关键

发作性喘息伴哮鸣音 多在接触过敏原、夜间凌晨发作或加重

可能可能最可能（2019）

- 呼气性（2018、2020）
  - 呼气音延长
  - 发作期 X 线可见双肺透亮度增加
- 哮鸣音 ——
  ①典型发作：双肺弥漫（广泛细支气管痉挛）
  ②非发作期或轻度发作：无或散在哮鸣音
  ③危重发作：可有沉默肺（哮鸣音减弱或消失）

检查

- 肺功能
  - 发作时呈阻塞性通气障碍 —— $FEV_1/FVC < 70\%$、$FEV_1 < 80\%$ 预计值、PEF ↓、RV ↑、RV/TLC ↑
  - 可变气流受限
    - 支气管激发试验阳性（2020）
      - 气道高反应性
      - 吸入组胺等 FEV_1 下降≥ 20%
      - 仅用于非发作期、$FEV_1 > 70\%$ 预计值
    - 可逆气流受限
      - 支气管舒张试验阳性（2008、2019） —— 吸入沙丁胺醇等 FEV_1 增加≥ 12%+ ≥ 200ml
      - PEF（监测变异率以评估病情） —— 日变异率＞ 10% 或周变异率＞ 20%
- 评估气道炎症和激素治疗反应性 —— FeNO ↑、痰嗜酸性粒细胞↑

治疗

- 防治哮喘最有效：脱离变应原
- 治疗哮喘最有效的药 - 糖皮质激素 —— 长期控制炎症：首选吸入 ICS（2019）
  迅速缓解症状：严重尽早静脉用激素
- β_2-R 激动剂 —— 长期控制炎症：最常用吸入 ICS+LABA（不能单用 LABA）
  迅速缓解症状：首选吸入 SABA（沙丁胺醇 / 特布他林，2009、2016）
  - 心源性哮喘和严重支气管哮喘若难以鉴别：
    ①吸入 SABA 或静注短效茶碱
    ②禁用肾上腺素、吗啡
- 白三烯调节剂（孟鲁司特，2015） —— 除 ICS 外唯一可单用控制炎症“白糖”
  尤其适合伴过敏性鼻炎、阿司匹林哮喘、运动性哮喘“baiby 啊运动”
- 严重哮喘急性发作（2011、2012、2021、2026）
  - 端坐呼吸、大汗、明显三凹征和奇脉、呼吸频率＞ 30 次 / 分等（2023）
  - 首选血气分析 —— 呼酸（病情恶化）：PaO_2 ↓、$PaCO_2$ ↑（肺泡通气量↓，2020）
    哮喘可呼碱：PaO_2 ↓、$PaCO_2$ ↓（过度通气）
  - 持续吸入 SABA+SAMA
    尽早静脉用激素、茶碱、吸氧、补液，pH ＜ 7.2 可补碱
    经治疗后 $PaCO_2$ ≥ 45、胸腹矛盾运动或意识障碍（危重度）→机械通气（意识障碍需有创机械通气）

奇脉 / 吸停脉小结 “C 魔小说包邮” —— 严重的心包积液（心脏压塞）、缩窄性心包炎、右心衰、支气管哮喘、COPD、胸膜疾病（大量胸腔积液、张力性气胸）